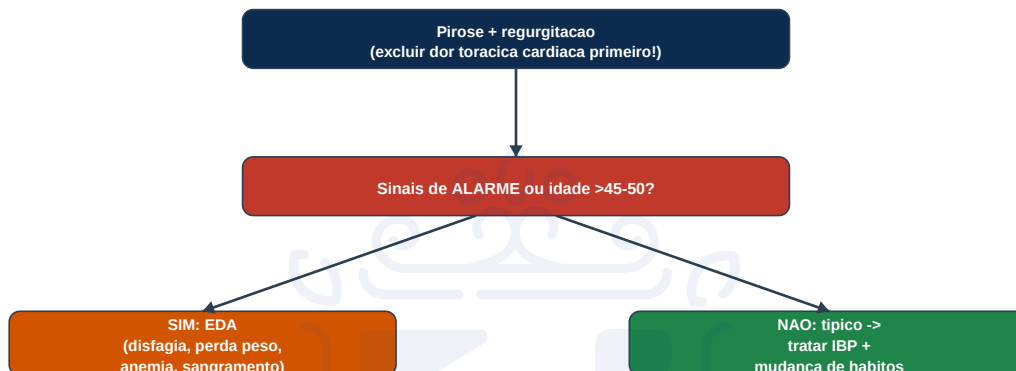


DRGE — DIAGNÓSTICO, ALARME E TRATAMENTO

FLUXOGRAMA — PIROSE NO PS

DRGE — EXCLUIR O GRAVE, TRATAR O TÍPICO



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Exposição anormal do esôfago ao ácido gástrico, gerando sintomas e/ou lesão da mucosa
- Prevalente (12-20% da população urbana brasileira); tratamento tipicamente AMBULATORIAL
- Mecanismos: relaxamentos transitórios do EEI, hipotonia do EEI, hérnia hiatal
- Aumento da pressão intra-abdominal e atraso do esvaziamento gástrico pioram o refluxo

QUANDO SUSPEITAR

SINTOMAS TÍPICOS E ATÍPICOS

- Típicos: PIROSE (queimação retroesternal) e REGURGITAÇÃO, ligadas à alimentação e ao decúbito
- Atípicos: tosse crônica, rouquidão, pigarro, amigdalites de repetição, globus faríngeo
- Asmáticos de difícil controle apesar de medicação correta
- Melhora momentânea com antiácidos; piora com refeições copiosas/ácidas (café, molho de tomate)
- No PS, a DRGE é causa frequente de dor torácica — excluir causa cardíaca primeiro

RED FLAGS — QUANDO SOLICITAR EDA

SINAIS DE ALARME

- Disfagia, sangramento (hematêmese/melena), perda de peso, anemia
- História familiar de câncer gástrico/esofágico em parente de 1º grau
- Idade > 45-50 anos; sintomas refratários ao tratamento
- Suspeita de complicação (estenose péptica); presença isolada de sintomas atípicos
- DRGE isolada NÃO se relaciona ao H. pylori — não pesquisar de rotina (só se dispepsia/epigastralgia)

DIAGNÓSTICO

QUANDO E COMO

- Diagnóstico CLÍNICO é efetivo (porém pouco específico): sintomas típicos sem alarme -> tratar sem exames
- EDA não confirma DRGE por si; esofagite grau B em diante + sintomas confirmam de forma indireta
- pHmetria: confirma em casos refratários ou pré-cirúrgicos — suspender IBP até 1 semana antes
- Manometria: pré-operatória, para programar a abordagem cirúrgica
- Os IBP melhoraram tanto o tratamento que a cirurgia tornou-se cada vez mais incomum

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Rx IBP E ALTERNATIVAS

IBP (não têm início de ação imediato): Omeprazol 20mg/dia (máx 40mg 2x), Pantoprazol 40mg/dia, Esomeprazol 40mg/dia, Lansoprazol 30mg/dia, Rabeprazol 20mg/dia, Dexlansoprazol 60mg/dia (sem superioridade entre eles)

PCAB: Vonoprazana 20mg/dia (dispensa jejum; opção em refratários)

Antagonista H2 (2a linha/adjuvante noturno): Ranitidina 150mg 2x ou 300mg à noite

PROCINÉTICOS NÃO são recomendados na DRGE (apenas em síndromes funcionais pós-prandiais)

No PS: se excluídas complicações, não há necessidade de iniciar IBP no pronto-atendimento

MUDANÇAS DE ESTILO DE VIDA (alta)

ORIENTAR

- ☐ Evitar alimentos-gatilho: álcool, café, chocolate, gordurosos, apimentados, tomate
- ☐ Elevar a cabeceira da cama
- ☐ Perda de peso em obesos
- ☐ Evitar decúbito lateral direito; não deitar logo após refeições
- ☐ Manter IBP/medicação conforme prescrição e seguimento ambulatorial

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO (apenas complicações)

INTERNAR SE

- Sangramento digestivo alto por esofagite grave
- Perfuração esofágica
- Estenose esofágica com disfagia grave / impossibilidade de alimentação
- Desidratação grave por vômitos incoercíveis
- Sem complicações + sem critério de internação = ALTA com seguimento

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA O AMBULATÓRIO

- Paciente com sintomas de DRGE (típicos/atípicos) há ____; causa cardíaca de dor torácica excluída.
- Sinais de alarme: sim/não (disfagia/perda de peso/anemia/sangramento). Idade > 45-50: sim/não.
- Conduta: IBP + mudanças de estilo de vida; EDA indicada por ____.
- Encaminhamento à gastroenterologia para seguimento / pHmetria se refratário.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente de 35 anos, pirose e regurgitação típicas, sem sinais de alarme. Qual a conduta inicial?

- A) Endoscopia digestiva alta obrigatória
- B) Iniciar IBP e mudanças de estilo de vida (diagnóstico clínico, sem necessidade de exames)
- C) pHmetria imediata
- D) Pesquisa de *H. pylori* de rotina
- E) Procinético como primeira linha

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado indica a realização de endoscopia digestiva alta no paciente com sintomas de refluxo?

- A) Pirose ocasional
- B) Disfagia, perda de peso, anemia ou sangramento (sinais de alarme)
- C) Melhora com antiácido
- D) Sintomas há 2 semanas em jovem
- E) Regurgitação após café

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o uso de procinéticos na DRGE, é correto:

- A) São primeira linha de tratamento
- B) Não há recomendação para uso na DRGE (apenas em síndromes funcionais pós-prandiais)
- C) Substituem o IBP
- D) Curam a esofagite
- E) São obrigatórios em todos os pacientes

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Antes de realizar pHmetria para confirmar DRGE em paciente sem diagnóstico, qual cuidado é necessário?

- A) Iniciar IBP na véspera
- B) Suspender o IBP até 1 semana antes (evitar falso-negativo)
- C) Fazer em jejum de 30 minutos apenas
- D) Administrar procinético
- E) Realizar durante uso de antiácido

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual orientação de estilo de vida é adequada na DRGE?

- A) Deitar logo após as refeições
- B) Elevar a cabeceira da cama, perder peso e evitar alimentos-gatilho
- C) Aumentar o consumo de café
- D) Dormir em decúbito lateral direito
- E) Fazer refeições copiosas à noite

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Em paciente jovem com sintomas típicos e sem sinais de alarme, o diagnóstico é clínico: inicia-se IBP e mudanças de estilo de vida, sem necessidade de EDA ou pesquisa de *H. pylori* (que não se relaciona à DRGE isolada).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Sinais de alarme (disfagia, perda de peso, anemia, sangramento, HF de câncer, idade >45-50, refratariedade) indicam EDA para excluir complicações e neoplasia.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Procinéticos não são recomendados na DRGE; seu uso restringe-se a síndromes funcionais (desconforto pós-prandial). O pilar é o IBP associado a mudanças de estilo de vida.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Para a pHmetria diagnóstica (paciente sem diagnóstico), suspende-se o IBP até 1 semana antes, evitando resultado falso-negativo pela supressão ácida.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Medidas eficazes: elevar a cabeceira, perder peso em obesos, evitar alimentos-gatilho (álcool, café, gordura, tomate) e não deitar após refeições — reduzem a exposição ácida.

SM24
Suporte ao Plantão Médico